

Các nghiên cứu về Lignospan trên súc vật chứng tỏ khả năng gây ung thư và đột biến hoặc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản là không có.

Người mang thai:

*Tác dụng gây quái thai: (nhóm B) các nghiên cứu về sinh sản được thực hiện ở chuột cống với liều gấp 6,6 lần liều cho người và không thấy có biểu hiện bất lợi cho thai do Lidocain gây ra. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu đầy đủ và được kiểm soát kỹ ở người mang thai. Các nghiên cứu về sinh sản của động vật không phải luôn dự báo chính xác cho đáp ứng của người. Cần cân nhắc tổng quát yếu tố này trước khi dùng Lidocain cho người mang thai, đặc biệt trong thời gian đầu của thai kỳ, khi sự hình thành của các cơ quan diễn ra mạnh nhất.

****Thời kỳ cho con bú:***

Vẫn còn chưa biết thuốc này có bài tiết qua sữa người hay không? Vì nhiều thuốc bài tiết qua sữa nên cần thận trọng khi dùng Lidocain trong thời kỳ đầu cho con bú.

Sử dụng trong nhi khoa:

Liều dùng trong nhi khoa cần giảm, thích hợp với tuổi, cân nặng và tình trạng sức khỏe (Xin đọc phần "Liều dùng và cách dùng ")

Các phản ứng có hại:

Các phản ứng có hại sau khi dùng Lidocain tương tự về bản chất với những phản ứng được thấy khi dùng thuốc gây tê cục bộ khác cùng nhóm amid . Những phản ứng này nói chung liên quan đến liều và có thể cho nồng độ cao trong huyết tương vì liều cao quá mức, hấp thu nhanh do tiêm vào mạch không chủ định hoặc có thể do quá mẫn cảm, đặc ứng hoặc giảm dung nạp ở một số người bệnh. Những phản ứng có hại nghiêm trọng thường xảy ra toàn thân. Các loại phản ứng sau đây thường được ghi nhận hơn cả.

Hệ thần kinh trung ương:

Biểu hiện của thần kinh trung ương kích thích và trầm cảm, có thể đặc trưng bởi chứng nhức đầu nhẹ, bồn chồn, lo âu, sáng khoái, lẫn, chóng mặt, ngủ gật,ù tai, mờ mắt, nhìn đôi, nôn, nhạy cảm với nóng lạnh tê cóng, co giật co, bất tỉnh, suy và ngừng hô hấp. Biểu hiện kích thích có thể rất ít hoặc không xuất hiện, trong trường hợp này, biểu hiện đầu tiên của ngộ độc có thể là ngủ gât kết hợp với bất tỉnh hoặc ngừng hô hấp sau khi dùng Lidocain thường là dấu hiện sớm của nồng độ thuốc cao trong máu, có thể coi như hậu quả của sự hấp thu nhanh.

Hệ tim mạch:

Biểu hiện về tim mạch thường là suy giảm, đặc trưng bởi nhịp tim chậm, hạ huyết áp và trụy tim mạch, có thể dẫn tới ngừng tim. Dấu hiệu và triệu chứng của các nặng tim mạch bị suy giảm thường có thể do một phản ứng của mạch thần kinh phế vị, đặc biệt nếu người bệnh ở vị trí đứng Những triệu chứng ít phổ biến, có thể là do tác dụng trực tiếp của thuốc . Sự không nhận ra dấu hiệu giám sát như thoát mồ hôi, cảm giác ngất, biến đổi ở mạch hoặc trung tâm cảm giác, có thể gây ra giảm oxynão tiến triển và còn lại biến tim mạch nghiêm trọng. Việc điều trị bao gồm đặt người bệnh ở tư thế nằm và cho thở oxy. Điều trị hỗ trợ chứng suy tuần hoàn có thể đòi hỏi truyền dịch tĩnh mạch và khi phù hợp, dùng chất co mạch (như epherin) được chỉ định tùy trạng thái lâm sàng.

Di ứng:

Phản ứng dị ứng được đặc trưng bởi những tổn thương ở da, mê đay, phù hoặc phản ứng phản vệ. Phản ứng dị ứng do nhạy cảm với Lidocain rất hiếm và nếu xuất hiện có thể được điều trị bằng phương pháp thông thường. Phát hiện sự nhạy cảm bằng phản ứng da chỉ có giá trị không chắc chắn.

Phản ứng thần kinh:

Tai biến về phản ứng có hại (như suy nhược thần kinh dai dẳng) kèm theo với dùng chất gây tê cục bộ có thể liên quan đến kỹ thuật đã áp dụng, tổng liều thuốc tê đã dùng, đường dùng và điều kiện thể lực của người bệnh.

Quá liều:

Tình trạng cấp cứu do thuốc tê nói chung có liên quan tới nồng độ cao trong huyết tương gặp phải trong quá trình điều trị dùng liều cao thuốc tê hoặc do vô tình tiêm vào mạch các dung dịch thuốc tê (Xin xem phần "Phản ứng bất lợi, cảnh báo và thận trọng").

Xử lý các trường hợp cấp cứu do gây tê cục bộ

Lưu ý đầu tiên là phòng ngừa, được thực hiện tốt nhất bằng cách giám sát cẩn thận và thường

xuyên các dấu hiệu sống còn về tim mạch và hô hấp và trạng thái tỉnh táo của người bệnh sau mỗi lần tiêm thuốc gây tê cục bộ. Khi có dấu hiệu bất thường đầu tiên cần sử dụng oxy ngay. Bước đầu tiên trong xử lý co giật là chú ý ngay việc duy trì đường thở thông suốt và thông khí có trợ giúp hoặc có kiểm soát với oxy và một hệ thống cung cấp cho phép đặt ngay áp lực đường ính trong đường thở nhờ mặt nạ. Ngay sau phần cơ bản của những biện pháp thông khí này cần đánh giá tương xứng của tuần hoàn và nhớ rằng những thuốc điều trị co giật đôi khi làm suy giảm tuần hoàn nếu tiêm tĩnh mạch. Có thể cần co giật dai dẳng, bất chấp việc trợ hô hấp và nếu tình trạng tuần hoàn cho phép, có thể tiêm tĩnh mạch thêm một lượng nhỏ loại barbiturat có tác dụng rất ngắn.(như thiopental hoặc thiamylal) hoặc một benzodiozepin (như diazenpam). Thấy thuốc lâm sàng phải quen dùng những thuốc chống co giật này trước khi dùng thuốc tê. Điều trị hỗ trợ suy giảm tuần hoàn có thể đòi hỏi truyền dịch qua tĩnh mạch và một thuốc co mạch (như ephedin) có thể được chỉ định tùy trạng thái lâm sàng.

Nếu không được xử lý kịp thời, cả chứng co giật và suy tim mạch đều có thể gây thiếu oxy, nhiễm acid chuyển hóa, nhịp tim chậm, loạn nhịp tim và ngưng tim. Nếu có ngừng tim, các biện pháp hồi sức tim phổi chuẩn phải được thực hiện ngay.

Đặt nội khí quản, dùng các thuốc và kỹ thuật quen thuộc với thấy thuốc lâm saàng sau khi khởi đầu bằng mặt nạ oxy. Nếu gặp khó khăn trong việc duy trì đường thở thông suốt hoặc nếu có chỉ định hỗ trợ thông khí lâu dài (có trợ giúp hoặc kiểm soát), thăm tách máu có giá trị không đáng kể trong trường hợp quá liều lidocain cấp tính.

Liều LD₅₀ của Lidocain HCL tiêm tĩnh mạch ở chuột nhắt cái là 26 (21-31) mg/kg và LD₅₀ tiêm dưới da là 26 (203-204) mg/kg.

Liều dùng và đường dùng

Liều Lignospan (Lidocain HCL và epinephrin) phụ thuộc vào tình trạng thể lực của người bệnh nhân, khu vực khoang miệng được gây tê, tình trạng tuổi máu của mô ở khoang miệng và kĩ thuật gây tê được dùng.

Nên dùng thể tích dung dịch gây tê nhỏ nhất có thể tạo hiệu quả gây tê cục bộ, cần có thời gian giữa các lần tiêm để theo dõi những biểu hiện của một phản ứng có hại. Về các kĩ thuật và qui trình gây tê đặc biệt ở khoang miệng, xin tham khảo trong tài liệu chuẩn.

Trong các thủ thuật gây tê thông thường nhất, Lignospan Standard (Lidocain 2% nồng độ epinephrine 1:100.000) được dùng nhiều hơn. Tuy nhiên khi ở độ sâu hơn và cần cầm máu, nên dùng Lignospan forte (Lidocain 2% nồng độ epinephrin 1:50.000)

Liều yêu cầu cần được xác định cụ thể từng trường hợp. Gây tê tiêm ngấm ở vùng miệng hoặc phong bế hàm dưới, liều khởi đầu là 1.0 - 5ml (0,5 2,5 ống).

Lignospan (Lidocain HCL 2% nồng độ epinephrin 1:50.000 hoặc 1:100.000) thường có hiệu quả.

Ở trẻ em dưới 10 tuổi, ít khi cần dùng nhiều hơn ½ ống (0.9 - 1ml hoặc 18 -20mg lidocain) cho 1 lần gây tê cục bộ thủ thuật liên quan tới răng đơn. Trong trường hợp gây tê tiêm ngấm hàm trên, lượng thuốc thường đủ để xử lý 2, thậm chí 3 răng. Tuy nhiên khi phong bế xương hàm dưới, sự gây tê thành công cũng đạt được khi phong bế bằng lượng thuốc này cho phép xử lý các răng ở cùng một góc.

Nên hút ra trước khi tiêm, vì điều này làm giảm khả năng bị tiêm vào mạch, do đó giảm thiểu tỉ lệ gặp tác dụng ngoài ý và hiệu quả gây tê kém. Tuy nhiên cần luôn luôn tiêm chậm.

Liều tối đa được khuyến cáo của Lignospan (Lidocain HCL 2% nồng độ epinephrin 1:50.000 hoặc 1:100.000)

Người lớn:

Với người lớn khỏe mạnh lượng Lidocain HCL được dùng nên ở mức dưới 500mg và trong bất kì trường hợp nào cũng không vượt quá 7m/g (3,2mg/lb) cân nặng.

Trẻ em:

Các bệnh nhi khó có thể khuyến cáo một liều tối đa của bất kì thuốc nào cho các bệnh nhi vì liều này biến đổi tùy thuộc vào tuổi và cân nặng. Với bệnh nhi dưới 10 tuổi có thể trọng và phát triển bình thường liều tối đa có thể xác định được bằng cách áp dụng một trong các công thức tính liều chuẩn (VD: quy tắc của Clark) - Ví dụ, ở những bệnh nhi dưới 5 tuổi cân nặng 50lbs, liều Lidocain HCL không được vượt quá 75-100mg nếu tính theo công thức của Clark. Trong bất kì trường hợp nào, liều tối đa của Lidocain HCL không vượt quá 7mg/kg (3,2mg/lb) cân nặng.

Ghi nhớ

Các thuốc dùng ngoài đường tiêu hóa phải được kiểm tra cảm quan các vi tiểu phần lạ và sự biến màu trước khi dùng bất cứ khi nào dung dịch và bao bì cho phép.

Được cung cấp như thế nào

Lignospan forte (Lidocain hydroclorid 2% và epinephrin 1:50.000) để tiêm được cung cấp trong lon hàn chân không chứa 50 ống 1.8ml (NDC 12862-1096-4) và trong hộp carton chứa 5 vỉ x 10 ống 1.8ml (NDC 12862-1096-7)

Lignospan Standard (Lidocain hydroclorid 2% và Epinephrin 1:100.000) để tiêm được cung cấp trong lon hàn chân không chứa 50 ống 1.8ml (NDC 12862-1095-3) và trong hộp carton chứa 5 vỉ x 10 ống x1.8ml (NDC 12862-1095-6)

Bảo quản ở nhiệt độ phòng dưới 25° C (77° F). Tránh ánh sáng, không được để lạnh.

Các lon: bảo quản tránh ánh sáng, giữ nguyên lon cho đến khi sử dụng. Khi đã mở, phải được đặt lại bằng nắp nhựa.

Các hộp: giữ tránh ánh sáng, giữ nguyên hộp đến khi sử dụng. Khi đã mở phải đặt lại bằng chính nắp trên hộp.

Không được dùng nếu màu chuyển sang hồng nhạt hoặc sẫm hơn màu vàng hoặc có tủa.

Tiết Khuẩn : Quy trình bảo quản và kỹ thuật

- Không được tiết khuẩn bằng Autoclave, vì không chịu được nhiệt độ và áp suất của Autoclave.
- Nếu đề nghị tiết khuẩn các ống thuốc bằng hóa học cả cồn isopropyllic (91%) hoặc cồn ethylic (70%) đều được khuyến cáo. Nhiều nhãn hiệu cồn rửa cũng như dung dịch cồn ethylic không đạt tiêu chuẩn được điển Mỹ, có chứa các chất làm biến chất gây hồng cao su và vì thế không được dùng. Việc tiết khuẩn bằng hóa chất chỉ được khuyến cáo thực hiện ngay trước khi dùng bằng cách lau rửa ống bằng một miếng bông đã tẩm bằng loại cồn được khuyến dùng.
- Một số ion kim loại nhất định (đồng, kẽm, thủy ngân ...) có quan hệ tới sự sưng lên và phù niêm mạc sau khi gây tê cục bộ trong nha khoa. Vì vậy, các chất tiết khuẩn hóa học có chứa các ion này hoặc còn sót lại các ion này không được khuyến dùng. Viên chống gỉ thường chứa atrinitrit hoặc các chất tương tự có thể sót lại các ion kim loại. Do đó, ống gắn nắp nhôm không được giữ trong các dung dịch này.
- Các muối amoni bậc 4, như benzalkonium clorid là các chất điện giải tương kỵ với nhôm. Các ống Lignospan được gắn bằng nắp nhôm, vì thế không được nhúng trong bất kỳ dung dịch nào có chứa các muối này.
- Để tránh rút dung dịch trong khi tiêm, phải đảm bảo đảm thủng tâm của màng cao su khi hút vào xi lanh. Việc đảm lịch tâm sẽ tạo ra một lỗ hình ovan cho phép dung dịch chảy xung quanh kim tiêm. Những nguyên nhân khác của việc rút, vỡ bao gồm xi lanh hồng, xi lanh có kim cong, có gợn móc, việc dùng các xi lanh không được thiết kế để hút ống 1.8ml và sự làm lạnh vô ý thức.
- Gây ống thủy tinh thường là kết quả của việc cố dùng một ống với pitong đã bị đẩy tuột ra. Pitong bị đẩy tuột ra bị mất độ trơn và khó có thể đưa trở lại ống. Vậy cần loại bỏ những ống có pitong tuột ra.
- Bảo quản ở nhiệt độ phòng dưới 25° C (77° F).

CHỈ DÙNG TRONG NHA KHOA, THEO SỰ KÊ ĐƠN CỦA THẦY THUỐC
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.
THUỐC ĐẠT TIÊU CHUẨN NHÀ SẢN XUẤT.
THỜI HẠN SỬ DỤNG: 24 THÁNG. KHÔNG DÙNG THUỐC QUÁ HẠN.

	Hàng hào chế biệt được SEPTODONT
	58 Phố Pont de Créteil
	94107- Saint Maur des Fossès - Cedex - Pháp
	ĐT : 01 49 76 70 00
	Fax: 01 48 85 54 01